

表2 咯血と吐血の鑑別

	咯 血	吐 血
症状	咳嗽とともに咯出	嘔吐とともに吐出
前兆	喉頭の違和感、臭い	悪心
色調	鮮紅色	暗赤色
性状	泡沫状、凝固しない	塊状、凝固する
混在物	喀痰、膿性痰	食物残渣
持続	しばらく続く	短時間で反復する
糞便	黒色便少ない	黒色便、タール便、下血
pH	アルカリ性	酸性
顕微鏡的所見	ヘモジタリン貪食マクロファージを認める	
他の症状	胸部所見、X線異常	腹部症状

[福井次矢ほか(編):内科診断学,医学書院,2000より作成]

まとめた。

その他、血痰の既往（繰り返しているのか初回の出血か）、呼吸器疾患と心疾患の既往、随伴する症状（咳、痰、発熱、胸痛など）、服薬歴（抗凝固療法など）、喫煙歴、外傷の有無、出血性素因の有無などの問診が重要である。

b 身体所見

眼瞼結膜の蒼白の有無、異常呼吸音としての断続性ラ音（肺炎、気管支拡張症）に注意する。咯血はその量によっては窒息や呼吸不全をきたすので、迅速に失血の状況を確認し、基本的な身体所見（意識状態、心拍数、血圧、呼吸数、呼吸状態、異常呼吸音）の評価でショック状態、呼吸不全状態であれば気管挿管など緊急処置を考慮する。外来受診時、止血していても、咯血量が中等症以上の場合は入院を考慮する。安易に帰宅させてしまうと重篤な結果につながりかねないので、慎重に判断する。

c 検査

i) 胸部X線、胸部CT

胸部X線検査は必須である。明確な血痰症例、喫煙歴や呼吸器疾患既往のある症例では胸部CTも必須であり、必要に応じて肺野のHRCT、造影CT、multi-detector CT angiography (MDCTA) を行う⁴⁾。

ii) 血液検査、尿検査、心電図

末梢血、凝固検査〔warfarin 内服患者での international normalized ratio (INR) を含む〕は必須で、大量咯血や肺出血では貧血の程度や進行が有用な情報となる。必要に応じて血管炎症候群、膠原病などの鑑別に腎機能および尿検査、抗好中球細胞質抗体 (anti-neutrophil cytoplasmic antibody: ANCA)、抗糸球体基底膜抗体など、自己抗体の検索を行う。慢性肝障害による凝固能低下の有無も重要である。

肺高血圧、心不全、弁膜症などによる咯血の鑑別も重要で心電図、必要に応じて心エコーを施行する。

iii) 喀痰検査

一般細菌、抗酸菌検査（培養含む）、細胞診を行う。近年、非結核性抗酸菌症〔*Mycobacterium avium* complex (MAC) 症など〕による気管支病変も増加しており、注意が必要である。

iv) 気管支鏡検査

気管支鏡検査はその適応症例や施行する時期については議論のあるところであるが、喫煙男性の持続する血痰症例では中枢型肺癌の除外のためには有用である。特に咯血早期に出血部位のフィブリン塊を安易に除去すると大出血を起こすことがあるので注意が必要である。

肺癌が疑われる症例、繰り返す血痰の症例では緊急対応のできる体制を整えて実施する。また肺出血が疑われる症例では、気管支肺胞洗浄 (bronchoalveolar lavage: BAL) が有力な診断の根拠となる。咯血に対する気管支鏡検査では可能な限り吸引チャンネルの大きい (2.6 mm 以上) 処置用スコープを使用する。

v) 気管支動脈造影

大量咯血に対しては治療としての気管支動脈塞栓術の適応も含め、気管支動脈造影は考慮すべき検査である。

治療・処置

咯血、血痰が少量で、緊急性を要さない場合は安静を原則として精査を進める。わが国では止血薬として carbazochrome, tranexamic acid が多用され、本邦でも tranexamic acid により院内死亡率低下、入院期間短縮、総医療費の抑制を示した報告がある⁵⁾。

咯血が中等量以上あるいは呼吸不全を伴う場合には入院が必要である。出血側を下にする側臥位安静が原則だが、肺出血や肺うっ血などは原因疾患に応じた体位をとらせる。大量出血で窒息の危険があるときは血管確保、気道確保を迅速に行い、特に持続する大量出血では、健側気管支への挿管など、出血していない側の肺の換気を守ることを優先する。

気管支拡張症や腫瘍のような局所病変からの大量出血では、気管支動脈塞栓術が有効となる。脊髄梗塞などのリスクに注意が必要だが、高い止血効果が得られる。気管支鏡下の処置については、止血薬注入なども行われるが有効性についてのエビデンスは少ない。その他、大量出血に対して責任気管支への EWS (endo-bronchial Watanabe spigot) 挿入術の有効性が報告されている⁶⁾。さらに出血コントロールが困難である症